



3

MOTIVOS DE CONSULTA EN LA ADOLESCENCIA

Dra. Patricia Goddard

Médica Pediatra, Especialista en Medicina del
Adolescente, Certificación SAP,

Especialista en Medicina del Deporte, UBA.

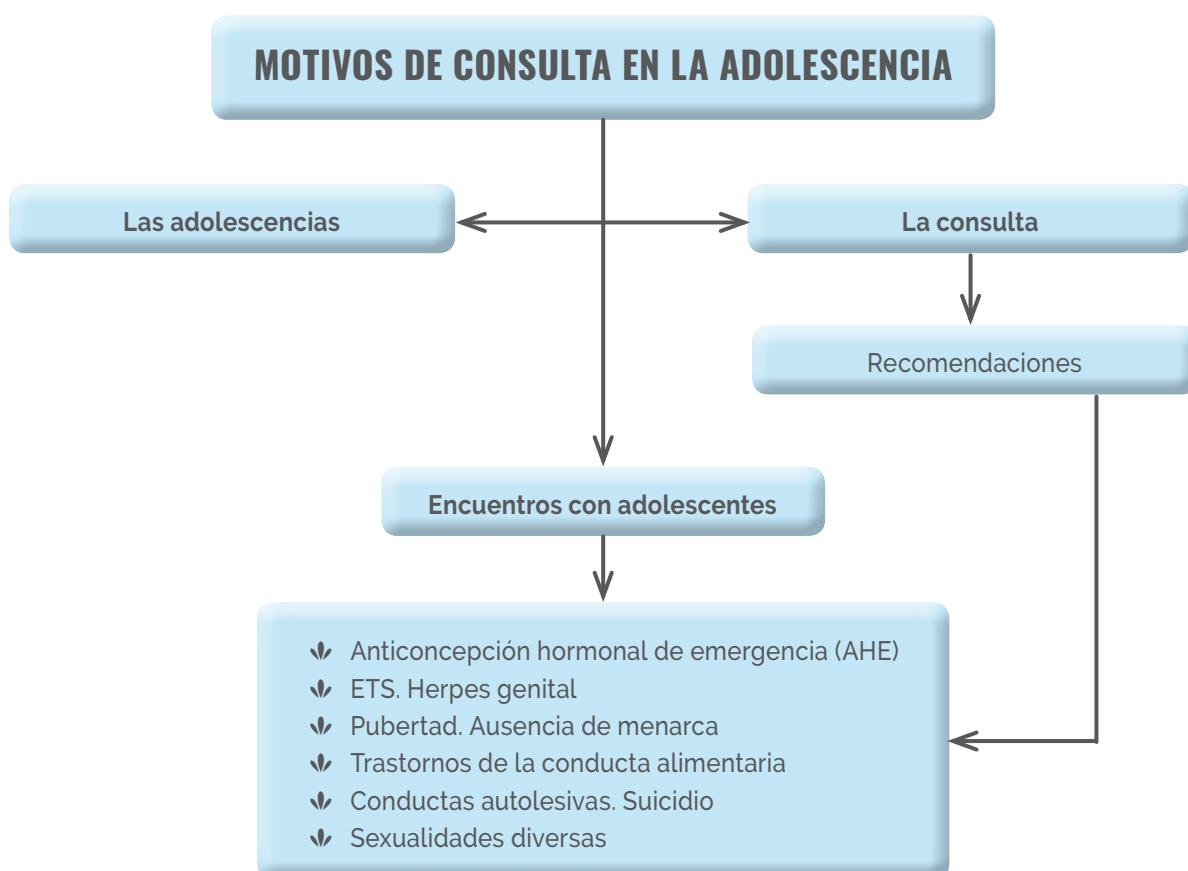
Coordinadora de Adolescencia, Departamento de
Pediatría, Hospital Alemán.

Secretaria del Grupo de Trabajo de Género, Sexualidad y
Diversidad en el curso de vida y Miembro del Comité de
Adolescencia, SAP.

Objetivos

- ✦ Comprender a la adolescencia como el momento del ciclo vital del ser humano más rico en posibilidades de aprendizajes y crecimiento en el que aparecen tanto desafíos como oportunidades.
- ✦ Visibilizar la diversidad que hay en las necesidades de los/las adolescentes, sus fortalezas y las situaciones de vulnerabilidad a las que pueden estar expuestos.
- ✦ Incorporar en la consulta la perspectiva de derechos, de género y de diversidad.
- ✦ Identificar y resolver las situaciones o los motivos de consulta más frecuentes.
- ✦ Considerar los diferentes aspectos o elementos que permiten establecer un vínculo de cuidado y acompañamiento a el/la adolescente.

Esquema de contenidos



Glosario

NNyA	Niños, Niñas y Adolescentes
SSyR	Salud sexual y reproductiva
AE	Anticoncepción de emergencia
AHE	Anticoncepción hormonal de emergencia
LNG	Levonorgestrel
AOC	Anticonceptivos orales combinados
DIU	Dispositivo intrauterino
RS	Relaciones sexuales
ETS	Enfermedades de transmisión sexual
VHS	Virus Herpes Simple
FSH	Hormona folículo estimulante
LH	Hormona luteinizante
TCA	Trastornos de la conducta alimentaria
IMC	Índice de masa corporal
BN	Bulimia nerviosa
AN	Anorexia nerviosa
TERIA	Trastorno evitativo/restrictivo de la ingesta de alimentos
TANE	Trastornos alimentarios no especificados
Género	Construcción cultural que hace referencia al conjunto de funciones, atributos e identidades construidos socialmente de mujer y hombre y al significado que se atribuye a esas diferencias
Binarismo	Categorización dicotómica del género y sus atributos varón/mujer
Identidad de género	Percepción subjetiva que tiene cada persona de su género
Cis-género	Persona cuyo sexo al nacer e identidad de género coinciden

Trans género	Persona que no se identifica con la identidad de género asignada al nacer de acuerdo con sus genitales
Varón trans	Se autopercebe como varón habiendo nacido con genitales femeninos
Mujer trans	Se autopercebe como mujer habiendo nacido con genitales masculinos
Intersex	Persona cuyas características sexuales no se ajustan a la definición binaria varón/ mujer.
Orientación sexual	Capacidad de una persona de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por personas de otro género, del mismo género, o de más de un género, y de mantener relaciones íntimas, afectivas y sexuales con estas personas
Grooming	Acoso sexual por parte de un adulto a través de las redes sociales
Sexting	Compartir imágenes y contenidos íntimos de índole sexual en las redes sociales, por WhatsApp o similar, que luego pueden ser reenviados sin consentimiento o robados

Introducción

La adolescencia es el momento del ciclo vital del ser humano más rico en posibilidades de aprendizajes y crecimiento.

Comprende la pubertad con los cambios corporales, los procesos psicosociales con la adquisición progresiva de habilidades cognitivas, emocionales y sociales, el manejo autónomo e independiente y la consolidación de procesos vitales como la Identidad, la vida relacional, la sexualidad y el proyecto vocacional.

Aberastury, A. y Knobel, M., explican el proceso adolescente como la elaboración inevitable y necesaria de tres duelos: el duelo por la pérdida del cuerpo infantil, el duelo por la pérdida de la identidad infantil y el duelo por la pérdida de la figura de los padres de la infancia, y la describen como etapa de crisis, inestable y tormentosa, que se manifiesta en las emociones y el comportamiento, (*La adolescencia normal: un enfoque psicoanalítico*, 1971).

El adolescente y quienes lo acompañan en este proceso se enfrentan con múltiples desafíos y oportunidades. Los pediatras se encuentran en un lugar de privilegio para acompañar y promover el desarrollo de potencialidades. Para ello, es importante considerar los paradigmas a partir de los cuales se piensan las adolescencias y las políticas de salud. Por otro lado, conocer las necesidades específicas del proceso adolescente, su realidad cotidiana y las características del entorno.

En la relación médico paciente con adolescentes se ponen en juego no sólo el conocimiento médico sino también el imaginario de cómo son los/las adolescentes, el modelo desde el cual actúa el profesional, sea éste el modelo médico hegemónico u otro, las vivencias de su propia adolescencia, las vivencias de la etapa vital que está atravesando, su esquema de valores y creencias acerca de la sexualidad humana, los estereotipos de género, los vínculos y las relaciones de poder.

Esto obliga a una constante revisión de las propias creencias, identificando preconceptos y prejuicios que condicionan la mirada y el accionar. Sólo entonces, se podrán capitalizar las oportunidades de intervención que la consulta con adolescentes ofrece.

A lo largo del texto se abordan los cambios de paradigmas, la consulta con adolescentes y jóvenes y recomendaciones para la misma.

Al finalizar, bajo el nombre de "Encuentros con adolescentes" para resaltar la singularidad de los mismos, se describen consultas seleccionadas, ya sea por su frecuencia, complejidad o impacto, o por la necesidad de sospecha para hacer el diagnóstico, mostrando las diversas formas en que los/las adolescentes se presentan a la consulta y las oportunidades de intervención que surgen.

Las adolescencias

Las representaciones sociales postmodernas de la adolescencia, aún vigentes en muchos sectores, incluyen tanto la visión de la juventud como paradigma de belleza y vitalidad, como la visión negativa de la juventud como "problema".

El concepto clásico de la adolescencia como período de transición entre la infancia y la adultez y de preparación para ocupar roles adultos, por definición deja sin "lugar" a los/las adolescentes siendo visibilizados sólo cuando alteran el orden, reforzando el concepto de "problema". La adolescencia es así "patologizada", convirtiéndose en depositaria o en la causa misma del problema, (Krauskopf D., 2003).

Estos paradigmas han sido cuestionados y remplazados por conceptualizaciones más integradoras. La psicóloga social Dina Krauskopf (2003), redefine el concepto de adolescencia como "un fenómeno multidimensional y diverso, atravesada por el entorno y el contexto histórico cultural en la cual se desarrolla, centrada en las capacidades y habilidades de los jóvenes, reconociendo sus capacidades de participar e incluso modificar su ambiente..." En esta línea, también la OMS propone poner énfasis en las potencialidades de los jóvenes y en su reconocimiento como sujetos de derecho.

Actualmente se habla de "las adolescencias" teniendo en cuenta la singularidad con que cada adolescente tramita el proceso adolescente, atravesado por múltiples factores como el contexto cultural y social en el que se encuentra, el género y los apoyos afectivos, nutricionales y educativos con los que cuenta y ha contado.

Hablar en plural de "las adolescencias", como señala Débora Kantor (2008), "apunta a desarmar los atributos naturales que se suponen conforman la adolescencia estableciendo una norma o un "deber ser" a cumplir, que califica y normatiza al adolescente y llama a la corrección cuando se aleja de la misma". Permite también visibilizar la diversidad que hay en sus necesidades, sus fortalezas y en las situaciones de vulnerabilidad a las que pueden estar expuestos: adolescencias en situaciones de exclusión social, migrantes, con discapacidad y/o enfermedades crónicas, con diversidad sexual, de pueblos originarios, son algunos ejemplos.

Otros hechos que han contribuido a promover cambios en las conceptualizaciones son el marco de Derechos Humanos y leyes que promueven y garantizan el ejercicio de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA), la ampliación del rango de

edad de 10 a 19 años de la Adolescencia para incluir a la Juventud definida entre los 15 y 24 años (OMS); los avances en la comunicación con la aparición de los teléfonos inteligentes y las redes sociales que permiten el acceso en tiempo real, ilimitado y global a la información, modificando la forma en que se construye el conocimiento y cómo las personas, especialmente los/las adolescentes, se vinculan socialmente.

Con frecuencia los adultos, incluyendo a los profesionales de la salud, siguen anclados en la visión del adolescente "problema" y a estereotipos, refiriéndose a ellos como vagos, aislados, adictos a las pantallas y a las sustancias, conflictivos, disruptivos en su vestimenta, en su lenguaje, en sus comportamientos sexuales, etc.

La antropóloga Victoria Barreda señala que estas valoraciones negativas surgen de los esquemas de pensamientos tradicionales mencionados y agrega: "La temporalidad es otra, el proyecto vital con la idea de proceso acumulativo y ascendente cambió y los adultos no tenemos elaborados nuevos esquemas de representación." Para los jóvenes actuales, el proyecto de vida clásico, lineal con logros preestablecidos, ya no se presenta como camino seguro de éxito e inserción social ni como única alternativa.

En este contexto, los adultos, ¿están brindando a los y las adolescentes una mirada amorosa y un marco referencial que los aloje y contra el cual pueden confrontar y diferenciarse? ¿les están ofreciendo aquello que necesitan?

La consulta en la adolescencia

Entendiendo a la salud como un concepto dinámico en el que intervienen múltiples determinantes (OMS, 2008), es necesario el abordaje de la salud con enfoque integral.

El concepto de Salud Integral del Adolescente es definido por la OMS como el bienestar físico, mental, social y espiritual de los jóvenes incluyendo aspectos relacionados con su desarrollo educativo, la adecuada participación en las actividades de la comunidad, acorde con su cultura, y el desarrollo de su máxima potencialidad.

El enfoque de la consulta es necesariamente biopsicosocial, con inclusión de perspectiva de género y diversidad y con foco en derechos, respetando los principios de autonomía progresiva, interés superior y participación directa de NNyA.

Incluir la **perspectiva de género** en la consulta implica reconocer, en un momento y contexto dado, cómo los estereotipos de género afectan la vida de las personas. Implica considerar los estereotipos y mandatos culturales respecto a lo que se espera de las mujeres y los varones que operan en forma desigual en detrimento de las mujeres.

La **perspectiva de diversidad** en la consulta reconoce las múltiples formas de ser, sentir y actuar de las personas, la diversidad de cuerpos y las distintas experiencias y expresiones de géneros y sexualidades.

Los enfoques de género y diversidad permiten a su vez, reconocer que las distintas feminidades, mujeres, identidades trans, lesbianas, intersex u otras, tienen

necesidades diferentes y específicas, encontrándose generalmente desfavorecidas respecto a los varones. Así también, permiten considerar las diversas masculinidades con sus necesidades y cómo operan las estereotipos y mandatos en ellos.

La **perspectiva de derechos en la consulta**: es considerar a los/las adolescentes como sujetos de derecho, respetando y promoviendo el pleno ejercicio a éstos.

Con frecuencia surgen inquietudes que pueden impactar negativamente en la calidad de atención creando barreras al ejercicio de sus derechos: ¿Puede ir un/a adolescente solo/a a la consulta? ¿A partir de qué edad? ¿Hay una edad mínima para poder recibir métodos anticonceptivos? ¿Qué alcances tiene la confidencialidad en la consulta? ¿Qué situaciones son de denuncia obligatoria? Las respuestas se enmarcan en las leyes que sustentan la perspectiva de derechos.

El marco normativo comprende la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y los diversos pactos internacionales refrendados por el país; la Ley Nacional N° 26.061 (2005) de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; la Ley Nacional N° 25.673 (2002) que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; la Ley Nacional N° 26.650 (2006) que creó el Programa Nacional de Educación Sexual, entre otras muchas leyes que regulan y promueven al acceso al ejercicio de derechos.

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACCESO AUTÓNOMO A LA ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL

Convención sobre los Derechos del niño

Niñxs: menores de 18 años

Interés superior del niñx / Autonomía progresiva / Participación directa / Derecho a ser oídx

Código Civil y Comercial:
Régimen especial de cuidado del propio cuerpo

Capacidad general de todas las personas / Modelo de familia basado en el respeto

Niñx: Interés superior
Autonomía progresiva
Representación o asistencia para el consentimiento

Adolescentes de 13 a 16
Pueden consentir toda práctica que no implique riesgo para su salud

Adolescentes mayores de 16
Capacidad plena para las decisiones sobre el cuidado de su propio cuerpo como persona adulta

Resolución 65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación: Marco interpretativo del CCyC.



Ley 26.061
Protección integral de niñx y adolescentes

Niñxs y adolescentes: personas menores de 18 años. Son sujetos de derechos - Autonomía progresiva.
Interés superior: la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley.

Ley 26.529
Derechos del paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado

Derecho a la Confidencialidad, Intimidad, Autonomía e Información.

Ley 26.150
Programa Nacional de Educación Sexual Integral

Derecho a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos del país.

Ley 25.673
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable

Derecho al acceso a la atención de salud sexual y salud reproductiva. Información clara, completa y oportuna.

Fuente: Infografía del Ministerio de Salud de la Nación, *Derechos de NNyA y acceso a la atención en salud integral*. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/derechos_personalisimos_de_ninas_ninos_y_adolescentes.pdf

- La perspectiva de derechos implica reconocer que los/las adolescentes, más allá de su edad, sexo, condición social, estado de salud o cualquier otra variable, son sujetos de derechos con capacidad de opinión y con derecho a recibir información, atención y acompañamiento para la toma de decisiones en relación con su salud, incluida la salud sexual y reproductiva.

MOTIVOS DE CONSULTA EN LA ADOLESCENCIA

No siempre es fácil identificar el motivo de consulta con adolescentes. Puede suceder que se presenten varios a la vez: el del adolescente, el de los padres o acompañantes (que puede o no coincidir), el referido por terceros como la escuela, otro profesional, el juzgado. Puede que se esté frente a un adolescente que dice no saber por qué vino o que no quiere hablar, o que pueda hablar recién después de varios encuentros, puede ser que el motivo manifiesto no sea el real y que haya un motivo no verbalizado.

El éxito de la consulta dependerá en gran parte, además de la idoneidad de la respuesta, de cómo transcurre el encuentro y cómo se vinculan el profesional y el/la adolescente. El encuentro dejará una impronta más allá de la situación por la cual consulta, incluso, en cómo se vinculará ese adolescente con otros profesionales y servicios en el futuro.

Las oportunidades de intervención están condicionadas por la calidad del servicio que se ofrece.

Históricamente, los motivos de consulta más frecuentes en el ámbito ambulatorio han sido:

- 👉 Certificado de aptitud física.
- 👉 Examen periódico en salud.
- 👉 Control del crecimiento y desarrollo, pubertad: ginecomastia, desarrollo genital, acné, la talla, menarca, telarca, flujo, trastornos menstruales, etc.
- 👉 Consultas relacionadas con salud sexual y reproductiva (SSyR).
- 👉 Cansancio. Cefalea. Dolor abdominal, mioarticular y torácico.
- 👉 Enfermedades infecciosas.

En los últimos años han aumentado, y a edades cada vez más tempranas, las consultas referidas a las sexualidades y la SSyR como las enfermedades de transmisión sexual (ETS), anticoncepción, embarazo, diversidad sexual.

De la misma forma, se han incrementado las consultas en salud mental como trastornos de ansiedad, ataques de pánico, depresión, conductas autolesivas y suicidio, y de otras problemáticas complejas como los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), sobrepeso y obesidad, consumos problemáticos de sustancias, enfermedades crónicas y discapacidades. Con frecuencia éstas se presentan en forma agrupada, como comorbilidades asociadas en el mismo paciente.

Las consultas por síntomas funcionales (algias, síntomas digestivos, cansancio, como ejemplos) son frecuentes y plantean el desafío de pesquisar situaciones subyacentes tales como embarazo, consumos, conflictos con pares o en el hogar, desórdenes alimentarios, de sueño, depresión, etc.

Recomendaciones para la consulta con adolescentes

Ambiente adecuado, privado, sin interrupciones.

Accesibilidad en los horarios.

Por parte del profesional

- ✦ Trato respetuoso.
- ✦ Presentarse y preguntar cómo quiere que se lo llame.
- ✦ Escucha empática.
- ✦ Tener en cuenta los tiempos del adolescente en la anamnesis y examen físico.
- ✦ Estar atento al lenguaje corporal.
- ✦ Evitar el rol paternalista o de par adolescente.
- ✦ No dar por sentado, no juzgar, no ser directivo.
- ✦ Explicar al inicio el marco de confidencialidad, el secreto médico y su alcance.
- ✦ Resguardar la privacidad.

Considerar los diferentes **motivos de consulta**: el motivo verbalizado o manifiesto; el motivo latente o paraconsulta, el referido por los padres que puede ser similar o diferente, por otro colega, institución, juzgado.

Pensar que puede estar atravesando situaciones de las cuales cuesta hablar, por no saber expresarlo, vergüenza, culpa, miedo, negación o creer que no se puede hacer nada al respecto.

La presencia de terceros: evaluar la oportunidad y/o necesidad del acompañamiento de un adulto referente. Ofrecer un espacio de privacidad, a solas, respetando su voluntad.

Ofrecer también un espacio de orientación y apoyo a la familia en común acuerdo con el adolescente.

La anamnesis integral. Respetando "el tempo" del adolescente y ampliando de acuerdo con el caso, revisar los diferentes aspectos de la vida del adolescente identificando situaciones problemáticas, estresores, factores protectores y de riesgo explorando: hogar y familia, escuela, empleo, alimentación, actividades con pares y

de tiempo libre, sexualidad, consumo de sustancias, depresión, suicidio, seguridad (uso de cinturón, casco, armas). Aprovechar también la oportunidad para revisar su vacunación y actualizar esquemas incompletos.



En el cierre, asegurarse de responder a la demanda del adolescente, aclarar dudas, evaluar la comprensión de las indicaciones, consensuar información a compartir con los padres y acordar la próxima visita.

Tener en cuenta la narrativa del adolescente: qué dice y cómo lo dice, como herramientas para abordar situaciones que de otra manera no son visibilizadas. Contextualizar el relato con su historia personal (escolaridad, vida social, enfermedades, eventos estresores), el funcionamiento familiar (familia disfuncional, separaciones, enfermedades) y apoyos con los que cuenta (familia extendida, escuela, otros adultos referentes, amigos).

Aplicar herramientas de Entrevista Motivacional: está técnica parte de las motivaciones y ambivalencias del paciente hacia el cambio respecto a una conducta determinada (Miller y Rollnick, 1991). Ayuda al cambio desde el proceso de la persona en lugar de dar indicaciones. Puede aplicar a cambios de hábitos de alimentación, sedentarismo, consumos, vínculos, etc. Apuntan al proceso de entender/saber y actuar. Usa preguntas abiertas: "¿por qué pensás que te está pasando esto?" "¿Cómo te sentís?"; preguntas facilitadoras: "dicen que para divertirse en la previa tenés que tomar alcohol ¿qué opinás?"; preguntas en espejo, ante "me enojé mucho con mi mamá" responder "te enojaste con tu mamá...", evita preguntas cerradas como "¿Tomás alcohol?" que tienden a cortar el diálogo y no invitan a la reflexión.

Considerar qué derechos están en juego: acceso a la atención sanitaria, a información, toma de decisiones, privacidad y confidencialidad etc. y si hubo situaciones de vulneración de derechos en su narrativa o en la atención.

Examen físico completo: incluye el Estadio puberal de Tanner y examen antropométrico; brindar información acerca de los cambios puberales reforzando la normalidad, pesquisar problemas inherentes a la etapa y enfermedades no aparentes (escoliosis, hipertensión, etc.).

Abordaje familiar: incluir a la familia en la atención siempre que sea posible brindando orientación y reforzando la red de contención del adolescente.

Trabajo interdisciplinario e intersectorial: es importante integrar miradas y acciones con otras disciplinas y articular acciones con la escuela, juzgados y recursos comunitarios disponibles.

Encuentros con Adolescentes

ROMINA. SUPERANDO BARRERAS.

LA PASTILLA DE “CUANTO ANTES”

Romina tiene 15 años, consulta con su pareja en Emergencias por dolor abdominal. Frente al médico relatan que les dio vergüenza decir el motivo real y que en realidad venían porque el día anterior tuvieron un accidente con el preservativo que se salió al retirar el pene luego de eyacular. Consultaron antes en otro centro donde no quisieron atenderlos sin la presencia de un adulto.

Según la Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva (ENSSyR) del 2013, en la Argentina, 62% de los varones y 52% de las mujeres entre 15 y 19 años iniciaron relaciones sexuales (RS), el 17% antes de los 15, y el 60% entre los 15 y 16 años.

- **En el 2017 el 13,5 % de los nacimientos en Argentina**
- **fueron de madres menores de 20 años y 2.493 nacimientos**
- **correspondieron a niñas y adolescentes menores de 15 años.**

Estas adolescentes suelen consultar tardíamente por motivos como desconocimiento de su cuerpo y sus funciones, negación, ocultamiento. Siempre sospechar la presencia de violencia sexual, ya sea en la relación que generó el embarazo o en su historia previa. En el total del 4% de mujeres en la ENSSyR cuyo inicio de RS fue forzado, éste sucedió antes de 16 años.

La historia de Romina como la de tantos otros adolescentes, visibilizan las barreras subjetivas al ejercicio de derechos (vergüenza, desinformación) y la vulneración de derechos cuando se les niega o existen condicionamientos para su atención sanitaria.

Las “oportunidades perdidas” observadas son: una educación sexual integral oportuna y adecuada, consejería en SSyR con prevención de ETS y prevención de embarazo con indicación de anticoncepción de emergencia y elección de un método anticonceptivo.

Los derechos en juego son el trato digno y el acceso al cuidado de la SSyR, a la información y consentimiento informado, a la confidencialidad y a la privacidad.

- **En ningún caso puede negarse la atención a un adolescente**
- **que se acerca sin un adulto para su atención.**

Más allá de la edad que objetivamente tenga, el interés superior del niño nos habilita a resolver a favor del acceso en tanto es la única forma de garantizar la protección y acceso al derecho a la salud.

ANTICONCEPCIÓN HORMONAL DE EMERGENCIA (AHE)

Se considera una urgencia y siempre debe ser atendida. Es importante que el pediatra este familiarizado y pueda dar respuesta sin dilaciones ni derivaciones innecesarias. Su indicación se encuentra enmarcada en la normativa legal y no requiere del consentimiento de un adulto. Es seguro y efectivo. No tiene contraindicaciones ni restricción de edad (criterio 1 de elegibilidad, OMS).

Puede prevenir más del 95% de los embarazos cuando se utiliza dentro de los 5 días o 120 horas posteriores a la relación sexual. A partir de las 12 horas de la relación sexual (RS) comienza a disminuir su efectividad ("pastilla de cuanto antes").

Múltiples mitos tanto entre los adolescentes como entre los adultos generan barreras al acceso: "es una bomba de hormonas", "no se puede tomar más de una vez al año", "puede causar problemas de fertilidad", "no se puede dar en adolescentes con menarca reciente", "es abortivo", perdiéndose así la oportunidad de evitar embarazos no planificados y abortos.

¿CUÁNDO SE INDICA LA AHE?

- ❖ Después de una relación sexual sin protección.
- ❖ En caso de rotura del preservativo o derrame de su contenido.
- ❖ Ante falla de la anticoncepción o utilización incorrecta.
- ❖ Ante agresión sexual si no cuenta con protección de algún anticonceptivo.

¿CÓMO SE INDICA LA AHE?

Levonorgestrel (LNG), 1,5 mg en una sola toma por vía oral. La opción de LNG 0,75 mg y repetir a las 12 horas tiene más efectos adversos. Inhibe o retrasa la ovulación y espesa el flujo cervical. En caso de embarazo, no lo interrumpe ni afecta al embrión.

No necesita examen físico ni estudios previos.

Si vomita dentro de las 2 horas posteriores a la toma, administrar una nueva dosis.

Luego de la toma, la menstruación puede venir en fecha, adelantarse o atrasarse.

Se puede reanudar el método anticonceptivo habitual o iniciar cualquier método de inmediato, incluido el DIU de cobre.

Los efectos secundarios son poco frecuentes, en general leves: náuseas y vómitos, sangrado vaginal irregular, fatiga. Si bien el uso repetido no plantea riesgos conocidos para la salud, puede dar lugar a una intensificación de los efectos secundarios, como las irregularidades menstruales.

En las adolescentes que toman anticonvulsivantes inductores de enzimas hepáticas o con sobrepeso y obesidad, índice de masa corporal (IMC) mayor a 25-30, la efectividad del LNG puede ser menor por lo que hay que ofrecer otras alternativas más eficaces. Se puede dar LNG 1,5 mg cada 12 o 24 horas, pero sin evidencia suficiente a la fecha.

Otras alternativas de AE son:

- ✦ Anticonceptivos orales combinados (AOC) con levonorgestrel 0,50 mg y etinilestradiol 100 ug, dos tomas separadas por 12 horas (método de Juspe). Se desaconseja por presentar más vómitos y náuseas.
- ✦ Dispositivo intrauterino (DIU) de cobre, es el método más eficaz de AE, puede colocarse hasta el 5^{to}-7^{mo} día post coito, es de larga duración, contraindicado en malformaciones uterinas, alergia al cobre, enfermedad inflamatoria pélvica; debe ser colocado por un profesional entrenado.

En todos los casos brindar información sobre el uso correcto del preservativo, el campo de látex, anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Explorar mitos y dificultades con el uso del preservativo, dificultad para negociar su uso, el consentimiento, relaciones sexuales bajo coerción, noviazgos violentos.

La edad, por sí misma, no constituye una razón médica para no otorgar anticoncepción. La elección del método debe ser libre e individual, brindando acceso a una variedad de opciones y teniendo en cuenta los factores sociales y de comportamiento.

En general, las adolescentes no tienen contraindicaciones para utilizar cualquier método anticonceptivo y los criterios de elegibilidad son los mismos que en adultas.

- **No existe un método anticonceptivo ideal, sino grupos ideales de adolescentes para un determinado método. Se promueve el uso de doble método sumando el preservativo.**

¿CUÁNDO PEDIR UNA PRUEBA DE EMBARAZO?

Ante atraso menstrual, sangrado irregular (escaso, marrón, a destiempo de su ciclo) o pérdida hemática por genitales externos. Falla del método usado: ruptura del preservativo, utilización de coito *interruptus* o *Billings*, olvido de la toma del anticonceptivo oral o presencia de vómitos o diarrea, toma del anticonceptivo de emergencia a destiempo luego de las 72 h. Ante cualquier duda expresada en relación con un embarazo. Cuando se sospeche, aun cuando la paciente no lo expresa o refiere no haber iniciado relaciones sexuales.

Ante una prueba de embarazo positiva:

- ✦ Evaluar las circunstancias del embarazo, no asumir relación consentida, evaluar riesgo ante sospecha o confirmación de abuso.
- ✦ Consejería en opciones orientado a reducción de riesgos y daños, en el marco de derechos.
- ✦ Evaluar si corresponde enmarcar en el Art. 86 del Código Penal que establece los causales de aborto no punibles.
- ✦ Informar que se le brindarán cuidados, contención y acompañamiento psicológico y social independientemente de la decisión que tome.
- ✦ Realizar la evaluación clínica, exámenes complementarios y tratamientos correspondientes, incluyendo ETS.

- ✦ Armar red de contención con personas de su confianza según sea su decisión. Tener en cuenta las posibles reacciones de la familia ante el develamiento y arbitrar el acompañamiento necesario.

Ante una prueba de embarazo negativa:

- ✦ Evaluar circunstancias que motivaron la consulta, RS bajo coerción, abuso, etc.
- ✦ Realizar abordaje integral, evaluación clínica y laboratorio según corresponda.
- ✦ Descartar ETS, indicar profilaxis si aplica y realizar prevención.
- ✦ Consejería en anticoncepción, jerarquizando los de larga duración. Hablar sobre anticoncepción de emergencia (AE). Indicar el método anticonceptivo elegido sin demora. Reforzar el uso del preservativo, revisar mitos y creencias.

Ante un caso de abuso sexual o sospecha fundada, se debe realizar la comunicación al organismo local de protección integral de Derechos de NNyA para garantizar su resguardo y para que impulse la acción penal. En caso de no poder concretar esta comunicación, se deberá hacer la denuncia ante las autoridades judiciales o policiales. En el 2018, la Ley 27455 reforma el Art. 72 del Código Penal, estableciendo que el abuso sexual en menores de 18 años deja de ser de instancia privada para ser de instancia pública, es decir, cualquier persona que tome conocimiento tiene responsabilidad de denunciar y el sistema de administración de justicia inicia acciones penales de oficio. Además, cuando sea necesario, arbitrar medidas de protección como la internación, para resguardar al adolescente.

ALEJO. ANTE EL DIAGNÓSTICO DE UNA ETS. HERPES GENITAL

Alejo tiene 15 años, consulta por dolor inguinal y disuria de un día de evolución. Poco comunicativo, se lo nota nervioso, niega relaciones sexuales (RS). Al examen físico general presenta adenomegalias dolorosas bilaterales, sin otros datos positivos. Acepta el examen genital, observándose lesiones pequeñas ulcerosas sangrantes en el glándulo y borde del meato uretral. Al explorar prácticas sexuales, cuenta que hace 10 días tuvo un encuentro sexual de contacto de genitales sin protección.

El herpes genital es una infección de transmisión sexual (ITS) frecuente, causado por el Virus Herpes Simple (VHS). El VHS1 se transmite por contacto dando lesiones en labios y zona bucal, aunque puede extenderse a la zona de los genitales a través del sexo oral. El VHS2 provoca herpes genital y se contagia a través del contacto sexual y del contacto cutáneo, siendo el que causa la mayoría de los casos recurrentes.

- **Es muy frecuente y contagioso, haya o no lesiones presentes.**
- **La mayoría de las personas infectadas no lo sabe por no tener**
- **signos ni síntomas o ser muy leves.**

CLÍNICA

Los síntomas pueden no presentarse, o aparecer entre 2 y 12 días después del contacto. Puede asociarse con fiebre, cefalea, mialgias y adenopatías inguinales, dolor, picazón o ardor local y disuria.

Se observan pápulas eritematosas y/o ampollas pequeñas, en ramillete, que al destecharse dejan úlceras y costras. Pueden hallarse en genitales externos, vagina, cuello uterino, ano, uretra, glúteos, muslos y boca. Con el rascado o el tacto pueden extenderse a otras zonas del cuerpo incluidos los ojos.

Se diferencian de la sífilis porque ésta presenta una lesión ulcerosa por lo general única, de bordes indurados y base limpia (chancro), no dolorosa y, en general, con mínimo compromiso ganglionar.

Las complicaciones son: sobreinfección, obstrucción uretral con retención urinaria, proctitis, meningitis, mayor riesgo de transmisión o contagio de otras ITS.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de una ETS genera angustia, vergüenza, miedos, culpa, enojo y desconfianza con la pareja. Requiere contención y una atención cálida, sin juzgamientos ni preconceptos. Tener en cuenta que muchas veces no se refieren prácticas sexuales que no involucran la penetración por no considerarlas de riesgo o por pudor. Sospechar independientemente de la edad y referencia de inicio de relaciones sexuales (RS) ya que puede tratarse de abuso o bajo coerción.

Realizar anamnesis y examen físico incluyendo genitales. Dado que el pronóstico y cuidado varían, es necesaria la confirmación por laboratorio del tipo de VHS utilizando:

- Detección de antígeno viral por ELISA o Inmunofluorescencia directa (IFD) por anticuerpos monoclonales, raspado de la lesión, sensibilidad 80%;
- Cultivo de células, sensibilidad del 90%, disminuye a partir de las 72 horas de la aparición de la vesícula;
- Serologías tipo específicos VHS 1 y 2. La sensibilidad para el VHS2 es de 80-98% y la especificidad mayor de 90%.
- Detección de ADN viral por reacción de polimerasa en cadena (PCR), no se utiliza en la práctica diaria.

TRATAMIENTO

En un primer episodio (Guías CDC, 2015):

Acyclovir	400 mg vía oral, tres veces por día por 7-10 días o,
Acyclovir	200 mg vía oral, cinco veces por día por 7-10 días o,
Valacyclovir	1 g vía oral, dos veces por día por 7-10 días o,
Famciclovir	250 mg vía oral, tres veces por día por 7-10 días.

Si la curación es incompleta a los 10 días, se puede extender el tratamiento.

El tratamiento precoz, dentro de las 72 horas, reduce el tiempo de resolución, alivia los síntomas y puede disminuir la recurrencia y transmisión, pero no es curativo. Las recurrencias se tratan con las mismas drogas en regímenes supresivos o episódicos.

Pesquisas: siempre realizar test de VIH dado que el VSH2 aumenta la susceptibilidad a la infección. Pesquisar también sífilis, gonococcia, *chlamydia*, VPH y Hepatitis C.

Vacunación: revisar y completar Hepatitis A, B y VPH.

Recomendaciones:

- ❖ No asumir su identidad de género, orientación o prácticas sexuales y preguntar sobre las mismas con respeto a la diversidad de cada una. De lo contrario, puede que no compartan información importante como situaciones de coerción o violencia, prácticas sexuales como el uso de sustancias en las RS (práctica conocida como "chemsex"). Estas situaciones quedan así invisibilizadas y se perpetúan, por no animarse a contarlos, no saber cómo, por falta de percepción de riesgo o pensar que no se puede hacer nada.
- ❖ Brindar información sobre el uso correcto del preservativo, el campo de látex, métodos anticonceptivos e información sobre ETS. El campo de látex se realiza a partir de un preservativo que se corta a lo largo y en el extremo cerrado, quedando un rectángulo que se utiliza como protección en el sexo oral-vaginal u oral-anal, o en el caso de contacto de genitales entre mujeres.
- ❖ Revisar mitos y dificultades en el uso del preservativo, cuando la pareja no lo quiere usar, vergüenza, consentimiento en las RS.
- ❖ Siempre que sea posible, incluir a la pareja sexual para consejería y testeo.

AYELÉN. PUBERTAD. AUSENCIA DE MENARCA

Ayelén tiene 15 años, está preocupada porque aún no tuvo su menarca. No tiene antecedentes personales de importancia. Su madre tuvo la menarca a los 14 años. Niega antecedentes personales y familiares de importancia. Refiere telarca a los 13 años. En el último tiempo creció mucho. Cambió su dieta para comer en forma más saludable con descenso de peso de unos 2 kg. No inició relaciones sexuales. Escolarizada con buen rendimiento. Muy deportista, es corredora y entrena 2 a 3 horas todos los días. Presenta un examen clínico normal con Tanner IV, Índice de masa corporal (IMC) 18. Se realiza laboratorio con rutina completa, perfil tiroideo, anticuerpos celiaquía, prolactina y hormonas Foliculo estimulante (FSH) y Luteinizante (LH), siendo éstos normales. Ecografía ginecológica: útero y anexos sin particularidades, ovarios con imágenes foliculares de 10 mm.

La consulta por **retraso o ausencia de menarca es frecuente**. Crea gran preocupación en las adolescentes y sus madres, pudiendo generar fantasías de anormalidad, enfermedad grave e incluso esterilidad.

La evaluación comprende anamnesis detallada, examen físico completo y estudios complementarios a solicitar según los hallazgos.

Los niveles de FSH y LH orientan al diagnóstico según sean hipo o hipergonadotróficos. La prolactina elevada sugiere adenoma hipofisario.



Siempre se debe descartar embarazo.

Considerar las pautas de desarrollo puberal normal:

La media de edad de la menarca en la Argentina es de 12,45 años (Del Pino y col, 2005), aproximadamente a los 2 o 3 años de la telarca y a los 6 meses del pico de velocidad de talla.

Dos tercios de las adolescentes tienen su menarca con un Tanner IV.

Los ciclos menstruales son en general irregulares en los 2 años post menarca.

A partir del 3^{er} año de edad ginecológica (EG), el 60-80% de los ciclos menstruales duran entre 21 y 34 días, estabilizándose a los 6 años de EG.

Se requiere un 17% de masa grasa para la menarca y un 22% para ovular.

¿QUÉ EVALUAR?

Historia familiar: desarrollo puberal de padre y hermanos, enfermedad tiroidea, enfermedades autoinmunes, diabetes, TCA, problemas menstruales.

Caracteres sexuales secundarios, cronología, edad de la telarca y pubarca.

Cambios de peso, sobrepeso u obesidad, cambios en la conducta alimentaria.

Inicio de relaciones sexuales, uso de anticonceptivos, síntomas de embarazo.

Dolor abdominal cíclico sugestivo de himen imperforado o malformación uterovaginal.

Actividad física, sobre todo de alto rendimiento, corredoras, bailarinas gimnastas.

Factores de estrés, problemas psicológicos.

Ingesta de medicamentos, consumo de sustancias recreativas.

Signos y síntomas de hipo o hipertiroidismo.

Signos de insulinoresistencia, acantosis nigricans en cuello, axila y otros pliegues.

Enfermedad sistémica: diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal, celiaquía, enfermedades crónicas como fibrosis quística, trastorno genético, disgenesia gonadal, fenotipo Síndrome de Turner.

Hiperandrogenismo por alteración ovárica, como poliquistosis ovárica, o suprarrenal.

Historia de cefalea y/o galactorrea, sugestivo de tumor hipofisario.

Presencia de anosmia sugestivo de síndrome de Kallmann, enfermedad genética que se caracteriza por déficit de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) e hipoplasia o aplasia de los bulbos olfativos resultando en un hipogonadismo hipogonadotrófico y anosmia o hiposmia congénito.

EXAMEN FÍSICO COMPLETO

Estadio de Tanner, velocidad de talla, percentilos de IMC, de talla y tensión arterial. Examen mamario y examen genital externo. El examen pélvico completo puede no ser necesario si no ha iniciado RS y el examen físico revela la causa de la amenorrea.

Se define **amenorrea primaria** ante:

Ausencia de menarca y de caracteres sexuales secundarios a los 14 años.

Ausencia de menarca a los 16 años con caracteres sexuales normales.

Ausencia de menarca a los 4 años de la telarca o luego del año de Tanner V.

Ausencia de menarca a los 14 años asociado a fenotipo síndrome de Turner.

Edad ósea de 13 años sin cambios puberales o de 15 años sin menarca.

CONDUCTA

Dado que su desarrollo puberal está dentro de parámetros normales y que su examen físico y el laboratorio descartan enfermedades que puedan predisponer a la amenorrea, la conducta con Ayelén es de seguimiento "activo": ofreciendo un espacio de consulta y orientación, abordando la conducta alimentaria para adecuar la dieta a la actividad deportiva, evaluando presencia de un TCA.

Considerar la conveniencia de disminuir la carga de ejercicio ya que el sobreentrenamiento predispone también a la amenorrea y, de este modo, prevenir la llamada **Triada de la atleta** que se da sobre todo en deportistas mujeres de alto rendimiento especialmente corredoras, bailarinas, gimnastas y está conformado por la triada: desorden alimentario, amenorrea hipotalámica funcional por déficit relativo de energía y densidad ósea disminuida por déficit de estrógenos, con riesgo de osteoporosis y fracturas por estrés.

- Las consultas referidas a la pubertad requieren del
- conocimiento de la pubertad normal y sus variantes y de la
- diversidad de condiciones que pueden alterarlas sin olvidar
- la percepción y el sentir del adolescente al respecto y su
- acompañamiento.

GUADALUPE, MARÍA Y EMILIO. TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

Guadalupe tiene 14 años, es traída a la consulta por cambios en su alimentación, con exclusión progresiva de alimentos sobre todo de alta densidad calórica y cambios en su conducta como cortar todo chiquito, tardar mucho en comer y esconder comida. Bajó 7 kg de peso en los últimos 4 meses. Ella refiere que no le gustan sus piernas y que desea ser más delgada. Se enoja y angustia cuando "come de más", siente que no

puede hacer nada bien, varias veces pensó en provocarse el vómito, pero no se animó. Hace ejercicio todos los días. Ciclos menstruales regulares.

María, 16 años, consulta por presentar dolor abdominal epigástrico y reflujo desde hace dos años. Refiere alimentarse "sano", por momentos no puede controlar las porciones que ingiere, y en ocasiones tiene vómitos postprandiales que dice son espontáneos. Ha tenido oscilaciones de peso mayores de 5 kg y menstruaciones cada 40 a 60 días. Al examen presenta hipertrofia parotídea. Hace gimnasia todos los días.

Emilio tiene 11 años, presenta un Tanner II. Es traído por bajo peso y negativa a comer. Refiere que no come porque tiene miedo a vomitar y siente rechazo ante varios alimentos, en especial la carne. Empezó con estas conductas hace unos meses, haciéndose progresivamente más restrictivo, recientemente bajó mucho de peso y hace unos días prácticamente no tiene ingesta. Se interna para realimentación requiriendo colocación de sonda nasogástrica e inicia tratamiento interdisciplinario. Se descarta patología orgánica.

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) se caracterizan por desviaciones en la ingesta alimentaria y una obsesión por el control de peso. Son trastornos de origen multifactorial, originados por la interacción de diferentes causas de origen biológico, psicológico, familiar y sociocultural.

Provocan consecuencias negativas tanto para la salud física como mental de la persona y pueden causar complicaciones graves en múltiples sistemas del organismo, incluso la muerte.



El diagnóstico e intervención temprana mejoran el pronóstico, requiriendo un alto índice de sospecha.

Puede presentarse en la consulta de muchas maneras: como una alerta por un descenso de peso no registrado, en un control de salud por cambio de hábitos alimentarios o de ejercicio; por síntomas relacionados con el bajo peso o con conductas de purgas (lipotimia, cefalea, dolor abdominal, reflujo gastroesofágico, caída de cabello, amenorrea); develamiento por parte del adolescente ante alguna complicación que le preocupa; para descartar una enfermedad orgánica grave "no puede comer, tiene náuseas y cada vez come menos, bajó mucho de peso".

Actúan como factores perpetuantes la desnutrición (al contribuir al aumento de endorfinas con estado de euforia y sensación de bienestar), la negación de la enfermedad, la distorsión de la imagen corporal, la pérdida de intereses, la gratificación social, la falla en sostén y pertenencia familiar.

Las familias suelen tener modelos de funcionamiento disfuncionales con características de aglutinamiento, sobreprotección, rigidez, falta de resolución de conflictos, conflicto parental que involucra al adolescente.

Guadalupe presenta una anorexia nerviosa (AN). Se caracteriza por una restricción del consumo energético que conlleva a un peso corporal marcadamente bajo o inferior a lo que minimamente se espera para su edad y estatura asociado a un miedo intenso a ganar peso, o a convertirse en obeso, o a conducta persistente para evitar ganar peso incluso estando por debajo del peso normal, a alteración de la percepción del peso o la silueta corporales, exageración de su importancia en la autoevaluación, o persistente negación del peligro que conlleva el bajo peso actual. La amenorrea fue descartada como criterio en el DSM V.

María, tiene diagnóstico de bulimia nerviosa (BN). Se caracteriza por episodios recurrentes de comer en exceso y un comportamiento compensatorio que puede presentarse con vómitos, purga, ayuno, ejercicio excesivo o una combinación de todas estas acciones.

El atracón se caracteriza por los dos hechos siguientes: ingestión, en un período determinado (ejemplo, dentro de un período cualquiera de dos horas), de una gran cantidad de alimentos y sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio. La hipertrofia de glándulas salivales es consecuencia de los vómitos y es un indicador del examen físico, al igual que las caries y callosidades en los dedos.

Emilio presenta un TCA conocido como Trastorno de la ingesta de alimentos evitativo/restrictivo o TERIA (ARFID por sus siglas en inglés).

Esta categoría fue incluida en el DSM V al modificar los llamados Trastornos alimentarios no especificados (TANE) que incluye los TCA que no cumplen con los criterios de AN ni de BN. El TERIA ha aumentado en los últimos años, se observa a edades más tempranas y es más frecuente en varones. Presentan: falta de interés aparente por comer o alimentarse; evitación a causa de las características organolépticas de los alimentos; preocupación acerca de las consecuencias repulsivas de la acción de comer; fracaso persistente para cumplir las necesidades adecuadas nutritivas y/o energéticas, asociadas a uno (o más) de los hechos siguientes: pérdida de peso significativa (o fracaso para alcanzar el aumento de peso esperado o crecimiento escaso en los niños); presencia de diferentes deficiencias nutricionales; dependencia de la alimentación enteral o de suplementos nutritivos por vía oral; interferencia importante en el funcionamiento psicosocial (Criterios DSMV).

CONSIDERACIONES

- **La anorexia nervosa (AN) en particular, tiene el rango de mortalidad más alto de cualquier trastorno psiquiátrico. El riesgo de muerte prematura es de 6 a 12 veces mayor en mujeres con AN comparadas a la población general, ajustado a la edad.**

Además de en niñas y mujeres, los TCA pueden darse en niños y hombre y personas con una gran variedad de cuerpos, pesos y tallas incluso con peso normal.

- **Cualquier situación de pérdida de peso abrupta en individuos sanos, o ganancia rápida o fluctuaciones de peso, debe ser investigada.**

En los niños y adolescentes investigar también ante la falta de ganancia del peso o estatura esperada y/o el retraso/interrupción del desarrollo puberal.

Se asocian con frecuencia con comorbilidades psiquiátricas.

El tratamiento requiere de un enfoque integral, apropiado a la etapa del desarrollo, multi e interdisciplinario, abordando los aspectos clínico-nutricionales, psicológicos, familiares y sociales. De acuerdo con la evolución y gravedad puede tratarse en forma ambulatoria, requerir dispositivos de Hospital de día o de internación.

SELENE Y MATÍAS. CONDUCTAS AUTOLESIVAS, SUICIDIO

Selene, tiene 14 años, concurre para el apto físico escolar. No refiere antecedentes personales ni familiares de importancia. Vive con sus padres y tres hermanos varones. Escolarizada, no repitencia. Problemas de socialización con sus pares. No inició relaciones sexuales. Niega consumos de sustancias. En el examen físico se observan cicatrices horizontales en el antebrazo, algunas recientes. No sabe precisar por qué, dice que es por "muchas cosas", sólo habló de ello con una amiga.

La autoagresión es el acto deliberado de producirse daño corporal sin un desenlace fatal, incluye cortarse, quemarse, golpearse o intoxicarse.

El Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, 5^{ta} Edición (DSM5) lo denomina "autolesión no suicida" y lo define como "una conducta por medio de la cual el individuo produce intencionadamente lesiones en su propia piel del tipo que suelen producir sangrado, hematoma o dolor, con la expectativa de que la lesión sólo conllevará un daño físico leve o moderado, buscando aliviar un sentimiento o estado cognitivo negativo, resolver una dificultad interpersonal o inducir un estado de sentimientos positivos".

 **El 16 a 18% de los adolescentes se han autoagredido alguna vez entre los 15 y 24 años. Se da con más frecuencia en mujeres. Se asocia fuertemente a características psicológicas personales y eventos vitales estresantes. La mayoría cesa en el tiempo. No necesariamente implica riesgo suicida.**

Suelen tapar las lesiones con la ropa y pulseras y no hablar de ello espontáneamente, por lo que es importante el examen físico con atención a antebrazos y muslos.

La pregunta dirigida en forma empática y oportuna puede ayudar a que lo cuenten. Con frecuencia el profesional puede ser la primera persona con quien lo hablan.

Hay que evaluar presencia de comorbilidades psiquiátricas, ideación suicida, abuso sexual y/o maltrato, abuso de sustancias, embarazo, trastornos alimentarios.

La intervención debe tener un enfoque integral e incluir el abordaje familiar. Es importante escuchar, reconocer el sufrimiento, hablar acerca de las circunstancias en las que ocurre, respetar sus tiempos y deseos de confidencialidad

Matías, tiene 15 años, consulta por cansancio, malestar general y algias inespecíficas. Como antecedente refiere un tío internado por depresión e intento de suicidio. Convive con ambos padres, es hijo único. Recientemente se mudaron a Buenos Aires. Repitente, cursa 2^{do} año. La madre refiere que desde que vinieron a Buenos Aires lo nota cambiado, se encierra en el cuarto, se enoja fácilmente, dejó de hacer cosas que le gustaban, no tiene apetito. En la entrevista a solas, Matías, refiere que se siente solo, triste, no tiene amigos, no habla con nadie de lo que le pasa, le cuesta ir a la escuela, a veces piensa que no vale la pena vivir.

La historia de Matías es la de un adolescente solo y sufriente que al encontrar un lugar de escucha con un profesional empático, puede hablar de lo que le pasa. Demasiadas veces estas consultas finalizan sin mediar diálogo ni contención, con una solicitud de laboratorio o a lo sumo con una derivación a salud mental sin tener en cuenta que esta consulta podría ser la última oportunidad para prevenir un suceso fatal.

La consulta por retraimiento, cambio de humor, llanto, disminución del rendimiento escolar, pérdida del apetito, abandono de actividades y/o síntomas físicos inespecíficos como dolores, cansancio, mareos, son señales de alarma que pueden preceder el intento de suicidio.

- **La mortalidad por suicidio en adolescentes creció más del 100% en las últimas décadas y es la segunda causa de muerte entre los 10 y 19 años.**

En la Encuesta Mundial de Salud Escolar (EMSE 2012), estudiantes de 13 a 15 años refirieron en el último año: sentirse casi siempre o siempre solo, 10%; consideraron seriamente la posibilidad de suicidarse, 16,9%; hicieron un plan acerca de cómo suicidarse, 16%.

Son **factores de riesgo**: los vínculos familiares inestables; fallecimientos; depresión; enfermedad crónica o discapacidad; abuso de alcohol y sustancias; abuso sexual, físico o psicológico; *bullying*, *ciberbullying*; aislamiento social, sentimientos de soledad y de fracaso, desesperanza; falta de interlocutores válidos; pérdida de la escolaridad; mudanzas, migraciones; antecedentes familiares de suicidio e intento de suicidio.

Son indicadores de **alto riesgo de suicidio**: la idealización de figuras que cometieron suicidio; los intentos de suicidio previos, ser usuario de páginas en internet de suicidio; tener acceso inmediato a un método (armas, drogas).

¿CÓMO PROCEDER?

Generar una relación de confianza y escuchar el relato reconociendo el sufrimiento

- **La mejor forma de saber si un/una joven tiene ideación suicida es preguntárselo, ya que no suelen comentarlo a menos que se les pregunte.**

Hablar del suicidio no activa "la idea de suicidio", por el contrario, el silencio aumenta el riesgo de concretar el intento.

Ampliar la anamnesis en forma empática y sin juzgamientos, evaluando el riesgo de intento de suicidio: presencia de ideación suicida, plan, presencia de factores de riesgo y/o indicadores de alto riesgo, sucesos recientes que pueden actuar como desencadenantes: pelea con amigos o con los padres, ruptura de noviazgo, fracaso en la escuela, fallecimiento, divorcios, etc.

Evaluar signos de abuso sexual y/o maltrato, presencia de embarazo, abuso de sustancias.

Identificar factores protectores personales y del entorno y adultos de confianza.

Derivación en forma personalizada a salud mental asegurando el contacto.

Cuando se requiera, el profesional y equipo de salud deben arbitrar recursos para su protección, como la internación, y articular con los dispositivos de atención interdisciplinaria e intersectoriales.

En caso de situación de vulneración o auto vulneración de derechos, solicitar intervención a la autoridad administrativa de protección de derechos del niño/a y adolescentes del ámbito local (Ley 26.061).

Tanto con Selene como con Matías, generar un espacio de acompañamiento para poder comunicar y hacer visible el malestar. Armar red convocando a sus padres o adultos referentes designados por él/ella, abordar emergentes personales y familiares y realizar las interconsultas pertinentes.

TATI, PABLO Y CARLA. SEXUALIDADES DIVERSAS

Tati. *Al preguntarle, pide que lo llame Tati en lugar de Mario, todavía no sabe qué nombre elegir, no se siente bien con su cuerpo de varón y quiere consultar para cambiarlo.*

Pablo *tiene 11 años, sus padres consultan porque le gusta maquillarse y lo ven afeminado. Pablo está triste y angustiado, "mis padres no me quieren así".*

Carla *tiene 12 años, viene con la madre quien comenta que Carla habla del "género fluido" y dice enamorarse de las personas, sean varones o mujeres.*

La diversidad sexual es un término que se usa para referirse de manera inclusiva a toda la diversidad de cuerpos, sexos, orientaciones sexuales e identidades de género, considerando que todos tienen derecho a manifestarse respetando los derechos de los demás.

En los últimos años han aumentado las consultas de adolescentes relacionadas con la sexualidad y la diversidad sexual. La diversidad se presenta como un espectro de posibilidades tanto en la autopercepción del género como en la orientación sexual fuera del orden binario heteronormativo establecido. Se presentan en la consulta, adolescentes que se autoperciben de manera diferente a los géneros binarios masculino/femeninos, como género no-binario o "Queer", una mezcla de ambos géneros binarios (bigénero), cambiando su identidad de género dependiendo del contexto (género fluido), entre otros. Esta fluidez también se presenta en la orientación sexual. No se debe asumir de antemano la identidad de género u orientación sexual de ninguna persona, preguntando siempre al adolescente al respecto. De lo contrario, podría suceder que no se le brinde la contención y orientación adecuada, vulnerando derechos y generando exclusión y mayor vulnerabilidad.

Por otro lado, se presentan a la consulta pediátrica configuraciones familiares diversas, familias uniparentales, homoparentales, madres o padres trans con acceso asistido a la parentalidad de diversas formas, consultas relacionadas con infancias trans, padres/madres que develan su identidad transgénero, entre otras.

Como garantes del acceso a la salud integral incluyendo la salud sexual, y del desarrollo de una vida afectiva y sexualidad libres, sin violencias ni discriminaciones, los pediatras deben informarse y capacitarse para dar respuestas acordes.

Requiere una mirada normalizadora y la puesta en práctica de habilidades de escucha empática, libre de preconcepciones y juzgamientos, sin directrices formateadas o estigmatizantes. Para ello, es necesario analizar la propia historia y los propios prejuicios y preconcepciones respecto a la sexualidad en general, respecto a la sexualidad en la infancia y adolescencia, la diversidad sexual, los mitos que la

atraviesan, los estereotipos de género, el impacto de estos estereotipos en las personas en lo personal y lo colectivo, el origen de la violencia de género.

El abordaje está enmarcado en derechos sustentados por la normativa legal vigente destacándose la Ley 27.743 de Identidad de género que toma la palabra de la persona como único requisito para determinar su identidad de género independientemente de su edad o condición.

RECOMENDACIONES PARA LA CONSULTA EN SEXUALIDAD INTEGRAL

No asumir la identidad de género ni orientación sexual.

Preguntar **“¿cómo querés que te llame?”** Registrar y llamarlo como tal.

Entrevistar a solas en algún momento, con su acuerdo, explicando la confidencialidad.

Usar preguntas disparadoras, abiertas, a modo de conversación, siguiendo el relato del adolescente, sin juzgar, sin directivas, sin etiquetar. Como ejemplos: ¿Con quién hablás de estos temas? ¿Y en el colegio? ¿De qué hablaron? ¿Vos qué opinás? ¿Cómo te sentís con tu cuerpo? ¿Te gustan los varones, las mujeres, los dos ...? ¿Tuviste relaciones? ¿Te cuidás? ¿Tuviste algún inconveniente? ¿A quién recurriste? ¿Tomás alcohol o consumís algo para tener relaciones? ¿Te pasó alguna vez de tener relaciones sin quererlo? ¿Cómo te llevás con tu pareja? ¿Es muy celoso/celosa? ¿Quedó algún tema sin hablar? ¡Qué buena pregunta!...

Explorar cómo se siente, qué grado de aceptación percibe en su entorno, sus hábitos.

Prevención de ETS y anticoncepción, de forma inclusiva, dando todas las opciones y considerando prácticas sexuales diversas.

Explorar consumos asociados a prácticas sexuales.

Pesquisar situaciones de abuso, maltrato, violencia en las parejas.

Tener en cuenta las redes sociales como fuente de información, de búsqueda de pareja y espacio de experiencias y prácticas sexuales.

Hablar del acoso virtual, *grooming* y *sexting*, práctica muy común entre adolescentes.

AUTOEVALUACIÓN 3



Identifique verdadero o falso en los siguientes enunciados

1. Hablar de "las adolescencias" permite visibilizar la diversidad que hay en sus necesidades, sus fortalezas y en las situaciones de vulnerabilidad a las que pueden estar expuestos.
V O F O
2. La perspectiva de diversidad en la consulta reconoce las múltiples formas de ser, sentir y actuar de las personas, la diversidad de cuerpos y las distintas experiencias y expresiones de géneros y sexualidades.
V O F O
3. En general siempre es conveniente centrarse en el motivo de consulta manifiesto, expresado por el/la adolescente.
V O F O
4. Es recomendable utilizar la entrevista motivacional privilegiando el uso de preguntas abiertas.
V O F O
5. Según la Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva (ENSSyR, 2013), en la Argentina, 62% de los varones y 52% de las mujeres entre 15 y 19 años iniciaron relaciones sexuales (RS), el 17% antes de los 15, y el 60% entre los 15 y 16 años.
V O F O
6. Para ofrecer anticoncepción hormonal de emergencia (AHE), las adolescentes menores de 15 años deben estar acompañadas por un adulto responsable.
V O F O
7. El herpes genital es muy frecuente y contagioso, haya o no lesiones presentes. La mayoría de las personas infectadas no lo sabe por no tener signos ni síntomas o ser muy leves.
V O F O
8. La consulta por retraso o ausencia de menarca es frecuente y siempre se debe descartar embarazo.
V O F O
9. La anorexia nervosa (AN) en particular, tiene el rango de mortalidad más alto de cualquier trastorno psiquiátrico. El riesgo de muerte prematura es de 6 a 12 veces mayor en mujeres con AN comparadas a la población general, ajustado a la edad.
V O F O
10. El 25% de los/las adolescentes entre 15 y 24 años se han autoagredido alguna vez, esta conducta implica riesgo suicida en todos los casos.
V O F O

Responda las siguientes consignas

1. Recuerde a alguno de sus pacientes adolescentes. Describa con 2 o 3 adjetivos a algunos de ellos/ellas.
.....
2. Defina el concepto de Salud Integral del Adolescente enunciado por la OMS.
.....
3. Enumere las situaciones en las que debe indicarse AHE.
.....
4. Describa la conducta que debe tomar el pediatra frente a un caso de abuso sexual o sospecha fundada del mismo.
.....
5. Mencione las recomendaciones que se deben tener en cuenta en la consulta con un/a adolescente con una ETS.
.....
6. ¿Cuáles son los motivos de consulta que son señales de alarma que pueden preceder el intento de suicidio?
.....
7. Mencione los factores de riesgo y los de alto riesgo que son indicadores de suicidio.
.....

Analice y resuelva la siguiente situación clínica

🔹 **Mariela** tiene 15 años viene acompañada por su hermana, de 17 años, por presentar mareos y molestias abdominales de 1 mes de evolución. Menarca 13 años, ciclo menstrual irregular, fecha de última menstruación incierta. Consultó con su madre previamente con otro médico que le indicó dieta. Examen clínico normal. Surge al realizar la anamnesis integral, que tuvo relaciones sexuales un par de veces con su novio, "él se cuidaba eyaculando afuera". Acepta realizar una prueba de embarazo.

1. ¿Qué es importante tener en cuenta ante una consulta por síntomas funcionales?
.....
2. Señale "oportunidades perdidas" observadas en la historia de Mariela.
.....
3. ¿Cuándo indicar una prueba de embarazo?
.....

Conclusiones

Como se ha ido mostrando a lo largo de este capítulo, la consulta en la adolescencia es una oportunidad para visibilizar problemas que pueden ser fuentes de sufrimiento y malestar, así como de riesgo, y que se manifiestan en el cuerpo, el comportamiento, el ámbito psicosocial, en algunos de ellos a la vez o en todos.



Con frecuencia, no son referidos por el/la adolescente siendo necesario mantener un alto índice de sospecha.

Los problemas pueden resultar simples, aunque de mucha preocupación para el adolescente como el acné, o complejos, como los TCA, la obesidad, consumo de sustancias, violencia, depresión, entre otros. La pesquisa de estas problemáticas es transversal a todas las consultas, más allá del motivo referido.

Además del impacto que éstos puedan tener en la salud del adolescente y en su calidad de vida, está comprobado que el estado de salud y comportamiento en la adolescencia tienen consecuencias en la calidad de vida y la salud en la adultez.

Los y las pediatras y demás profesionales de la salud, tienen una enorme responsabilidad como adultos referentes y efectores sanitarios de cuidar y propiciar la salud integral de los/las adolescentes. El encuentro en la consulta y el vínculo que se construya son potentes herramientas para ello. Asimismo, la inclusión de la familia y el reforzamiento de redes.

Las historias narradas objetivan las necesidades específicas de salud que tienen los/las adolescentes y la necesidad de servicios de salud adaptados. Los componentes básicos de estos servicios son: la capacitación de los profesionales, el abordaje integral con foco en derechos, la privacidad, la confidencialidad y la accesibilidad. La interdisciplina, el trabajo en equipo y la articulación con la escuela, otros sectores comunitarios y la justicia, son componentes necesarios para dar respuestas efectivas e integradas.

Lecturas recomendadas

- Academy for Eating Disorders (AED). Trastornos de la Conducta Alimentaria. Guía de Cuidados Médicos. Reporte AED, 3^{era} Edición, 2016.
- CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). Herpes genital: hoja informativa, 2017
- Métodos Anticonceptivos. Guía práctica para profesionales de la salud. AMADA y PNSSyPR, MSN, 2015.
- Ministerio de Salud de la Nación (MSN). Lineamientos para la atención del suicidio en adolescentes, 2012.
- Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia (2018): Guía sobre derechos de adolescentes para el acceso al sistema de salud.
- Ministerio de Salud de la Nación, Argentina. Dirección de Sida y ETS (2016): Guía básica de Diversidad Sexual.
- Mulli V, Pasqualini T. Trastornos menstruales en la adolescencia y dismenorrea. PRONAP Adolescencia, 2017; Módulo 3: 97-123.
- Pasqualini D, Longarela H. Depresión y adolescencia. PRONAP Adolescencia, 2017. Módulo 3: 9-38.
- Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia y UNICEF (2016): Situación de Salud de los y las adolescentes en la Argentina.

CLAVE 3



Identifique verdadero o falso en los siguientes enunciados

1. Verdadero.
2. Verdadero.
3. **Falso.** No siempre, los motivos de consulta pueden ser varios y diversos: el motivo verbalizado o manifiesto; el motivo latente o paraconsulta, el referido por los padres que puede ser similar o diferente, por otro colega, institución, juzgado.
4. Verdadero.
5. Verdadero.
6. **Falso.** En ningún caso puede negarse la atención a un adolescente que se acerca sin un adulto para su atención, independientemente de la edad y/o del motivo de consulta. Su indicación se encuentra enmarcada en la normativa legal y no requiere del consentimiento de un adulto. Es seguro y efectivo. No tiene contraindicaciones ni restricción de edad (criterio 1 de elegibilidad, OMS).
7. Verdadero.
8. Verdadero.
9. Verdadero.
10. **Falso.** El 16 a 18% de los adolescentes se han autoagredido alguna vez entre los 15 y 24 años. Se da con más frecuencia en mujeres. Se asocia fuertemente a características psicológicas personales y eventos vitales estresantes. La mayoría cesa en el tiempo. No necesariamente implica riesgo suicida.

Responda las siguientes consignas

1. ¿Ha escrito o pensado en características negativas o positivas? ¿De dónde han surgido para usted estas valoraciones? Muchas veces las valoraciones negativas surgen de los esquemas de pensamientos tradicionales. Para la mayoría de los jóvenes actuales, el proyecto de vida clásico, lineal con logros preestablecidos, ya no se presenta como camino seguro de éxito e inserción social ni como única alternativa.
2. El concepto de Salud Integral del Adolescente es definido por la OMS como el bienestar físico, mental, social y espiritual de los jóvenes incluyendo aspectos relacionados con su desarrollo educativo, la adecuada participación en las actividades de la comunidad, acorde con su cultura, y el desarrollo de su máxima potencialidad.
3. La AHE se debe indicar: después de una relación sexual sin protección; en caso de rotura del preservativo o derrame de su contenido; ante falla de la anticoncepción o utilización incorrecta; ante agresión sexual si no cuenta con protección de algún anticonceptivo.
4. Ante un caso de abuso sexual o sospecha fundada, se debe realizar la comunicación al organismo local de protección integral de Derechos de NNyA para garantizar su resguardo y para que impulse la acción penal. En caso de no poder concretar esta comunicación, se deberá hacer la denuncia ante las autoridades judiciales o policiales. En el 2018, la Ley 27455 reforma el Art. 72 del Código Penal, estableciendo que el abuso sexual en menores de 18 años deja de ser de instancia privada para ser de instancia pública, es decir,

cualquier persona que tome conocimiento tiene responsabilidad de denunciar y el sistema de administración de justicia inicia acciones penales de oficio. Además, cuando sea necesario, arbitrar medidas de protección como la internación, para resguardar al adolescente.

5. Recomendaciones: no asumir su identidad de género, orientación o prácticas sexuales y preguntar sobre las mismas con respeto a la diversidad de cada una. Brindar información sobre el uso correcto del preservativo, el campo de látex, métodos anticonceptivos e información sobre ETS. Revisar mitos y dificultades en el uso del preservativo, cuando la pareja no lo quiere usar, vergüenza, consentimiento en las RS. Siempre que sea posible, incluir a la pareja sexual para consejería y testeo.
6. La consulta por retraimiento, cambio de humor, llanto, disminución del rendimiento escolar, pérdida del apetito, abandono de actividades y/o síntomas físicos inespecíficos como dolores, cansancio, mareos, son señales de alarma que pueden preceder el intento de suicidio.
7. Son factores de riesgo: los vínculos familiares inestables; fallecimientos; depresión; enfermedad crónica o discapacidad; abuso de alcohol y sustancias; abuso sexual, físico o psicológico; *bullying*, *ciberbullying*; aislamiento social, sentimientos de soledad y de fracaso, desesperanza; falta de interlocutores válidos; pérdida de la escolaridad; mudanzas, migraciones; antecedentes familiares de suicidio e intento de suicidio.

Son indicadores de alto riesgo de suicidio: la idealización de figuras que cometieron suicidio; los intentos de suicidio previos, ser usuario de páginas en internet de suicidio; tener acceso inmediato a un método (armas, drogas).

Analice y resuelva la siguiente situación clínica

👉 Mariela

1. Mantener un alto índice de sospecha para la pesquisa de situaciones subyacentes no manifestadas tales como embarazo, consumos, conflictos con pares o en el hogar, de sueño, depresión, etc. Realizar una anamnesis integral y examen físico completo. Escucha empática y con atención a la narrativa del adolescente, qué dice y cómo.
2. Educación sexual integral oportuna y adecuada. Consejería en SSyR con prevención de ETS y embarazo, indicación del método anticonceptivo elegido. Diagnóstico temprano de embarazo.
3. Ante atraso menstrual, sangrado irregular o pérdida hemática por genitales externos. Ante falla del método usado: ruptura del preservativo, utilización de coito *interruptus* o *Billings*, olvido de la toma del anticonceptivo oral o presencia de vómitos o diarrea, toma a destiempo del AE. Cualquier duda expresada en relación con un embarazo. Ante sospecha por el cuadro clínico, aun cuando la paciente no lo expresa o refiere no haber iniciado relaciones sexuales.